



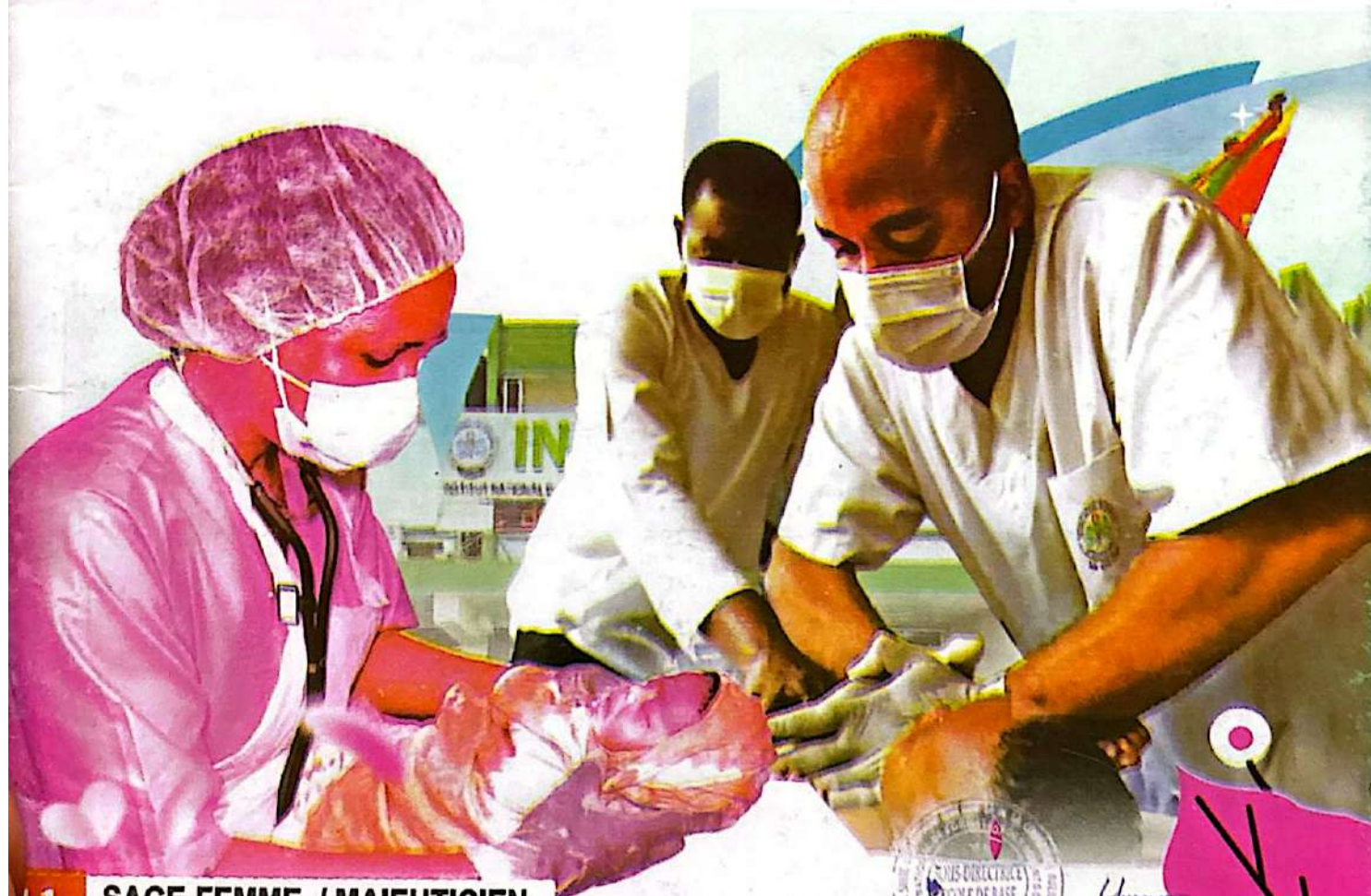
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE
ET DE LA COUVERTURE MALADE UNIVERSELLE



République de Côte d'Ivoire
Union - Énergie - Travail

UNITÉ PÉDAGOGIQUE PSYCHOSOCIO-ANTHROPOLOGIE

*Je suis étudiant à l'INFAS pour être un agent de santé nouveau.
Je suis responsable de mon apprentissage.
Je m'engage à devenir un agent de santé nouveau afin de prodiguer
des soins humanisés de qualité.*



L1
TC **SAGE-FEMME / MAIEUTICIEN**
INFIRMIER - INFIRMIÈRE

2025-2026



SUPPORTS DES COURS :
PSYCHOSOCIOLOGIE DE SANTÉ
.....
ANTHROPOLOGIE DE LA SANTÉ

SUPPORT DE COURS DE PSYCHOSOCIOLOGIE DE LA SANTE

SOMMAIRE

INTRODUCTION : DESCRIPTIF DU COURS.....	4
I. BREVES APPROCHES DE LA SOCIOLOGIE DE LA SANTE.....	4
II. INEGALITES SOCIALES EN SANTE.....	8
III. RISQUES SANITAIRES ET FACTEURS DE RISQUE.....	13
IV. DETERMINANTS DE L'UTILISATION DE L'OFFRE DE SOINS DANS UNE COMMUNAUTE.....	18
V. LES RELATIONS ENTRE LES INDIVIDUS DANS LES CENTRES DE SANTE.....	21
VI. LES CONDITIONS D'ADOPTION DE COMPORTEMENT EN SANTE.....	23
VII. QUELQUES THEORIES DU COMPORTEMENT DES INDIVIDUS EN MATIERE DE SANTE.....	25

INTRODUCTION : DESCRIPTIF DU COURS

La santé publique en intégrant différentes dimensions que sont les dimensions administratives, sociales, politiques et économiques de la santé vise aussi la préservation, la protection, la prévention, la restauration de la santé (groupe d'individus, pays, mondial) à travers la recherche, l'éducation, la mise en place des systèmes d'urgence....La santé publique, c'est selon l'OMS, « *la prise en charge collective de la santé d'une population dans son milieu de vie, qu'il s'agisse de soins, prévention, éducation ou hygiène sociale* ». Les différentes actions à mener dans ce contexte vont porter à la fois sur les individus, leurs comportements et leur environnement.

L'objectif majeur de ce cours est de montrer aux étudiants les différentes perspectives d'analyse des forces économiques, environnementales, sociales, politiques, culturelles qui façonnent le domaine de la santé. En d'autres termes, il s'agit d'amener les étudiants à observer l'existence des liens complexes et multiples qui se tissent entre la société et la santé des populations.

I. BREVE APPROCHE DE LA SOCIOLOGIE DE LA SANTE

I.1. La Sociologie

Tout en ayant les mêmes buts, la sociologie vise les groupes sociaux au lieu des individus pris isolément. La sociologie est une discipline des sciences humaines et sociales qui s'intéresse à la compréhension du social. Elle a pour objectif d'observer et d'analyser de manière compréhensive et/ou explicative les comportements humains, le fonctionnement et les transformations au sein de groupes humains et de définir la façon dont fonctionnent les individus en société. Elle prend pour objet d'étude les individus insérés dans des collectivités (organisations, classes sociales...).

L'environnement physique et social influence souvent le comportement des individus.

En d'autres termes, la position sociale des individus engendre parfois des comportements qui agissent à leur tour sur la santé.

I.2. La sociologie et la santé

L'intérêt sociologique pour la santé remonte au XIX^{ème} siècle où pour essayer d'enrayer les épidémies et d'autres maladies contagieuses, les médecins de l'époque ont pour la première fois cherché les causes de ces maladies dans les facteurs environnementaux.

La sociologie de la santé est une branche de la sociologie. Elle s'intéresse à l'institution médicale, c'est-à-dire les établissements socio-sanitaires publics et privés (la médecine comme institution sociale, c'est-à-dire objet de représentation (idées, croyances) et de pratiques n'est pas dissociable des autres institutions telles que l'économie, la famille, la religion, etc.), l'organisation et le fonctionnement de l'institution médicale, les comportements des professionnels de la santé ainsi que ceux des différentes catégories socioprofessionnelles de la santé, les rapports entre médecins et patients, les rapports entre l'institution médicale et le reste de la société, l'efficacité du système de santé, l'impact de l'institution sociale sur la population (le système de santé répond-il à l'attente de la société?), les services de protection sociale, etc.

En effet, pour apporter des réponses urgentes et efficaces aux problèmes de santé des populations, les Etats ont mis en place des systèmes de santé qui permettent de maintenir et d'améliorer l'état de santé des populations au regard de la définition de la santé donnée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : la santé est un état de complet bien-être physique, mental (psychique) et social.

Mais ces systèmes répondent-ils aux besoins des populations ? Comment fonctionnent-ils ? Quelles sont leurs principales caractéristiques ? Etc.

Ces questions sont aussi au cœur de la sociologie de la santé. Les études en sociologie de la santé portent principalement sur les déterminants sociaux, la médicalisation et les inégalités face à la santé.

I.2. Différentes approches de la santé et de la maladie

I.2.1. Approche biomédicale de la santé et de la maladie

Cette approche domine dans l'étude des maladies. Construite au XIX^{ème} siècle en Occident, elle l'emporte sur toutes les autres conceptions de la maladie dès le début du XX^{ème} siècle et repose sur une conception positiviste de la maladie qui a donné naissance à l'étiologie spécifique. L'étiologie est la science qui recherche les causes des maladies. Le positivisme postule que le principe de la connaissance se trouve dans l'observation objective des faits et que la preuve empirique obtenue de l'observation est la seule preuve scientifique acceptée. Dans l'approche positiviste, la maladie est saisie comme une entité que l'on peut isoler de l'individu qui en souffre (Corin, 1985). Ainsi, la maladie donne lieu à une série d'observation et de mesures qui permettent d'en préciser les caractéristiques objectives et généralisables. La maladie dépend de moins en moins de ce que l'œil peut voir ou de ce que le patient peut en dire.

A la faveur de l'approche positivisme, naît l'étiologie spécifique qui découle de la théorie microbienne : pour chaque maladie, il existe un agent pathogène ou un microorganisme que le chercheur doit déterminer. Cet agent pathogène est la cause de la maladie. La médecine s'intéresse aux causes et aux traitements des problèmes de santé en fonction des origines biologiques.

I.2.2. Approche biopsychosociale de la santé et de la maladie

L'approche biopsychosociale représente un élargissement dans la conception mécanique de la maladie. Elle ne remet pas fondamentalement en cause la conception biomédicale classique, mais prend en considération de nouveaux facteurs dans l'étiologie de la maladie. On parle alors d'étiologie sociale. Ces nouveaux facteurs sont liés à l'environnement physique ou social des personnes, les composantes psychologiques dans la maladie.

L'approche biopsychosociale est à l'origine des nouveaux déterminants de la santé qui font une large place à l'environnement et aux habitudes de vie. Selon cette approche, il convient de ne pas prendre seulement en considération le corps malade lors des traitements et des soins, mais aussi les différentes dimensions de la personne. D'où la présence des travailleurs sociaux pour le volet social, des biologistes, des médecins et des infirmiers, des psychologues, des psychiatres, etc.

I.2.3. L'approche écologique de la santé et de la maladie

Le modèle écologique ou systémique ou encore environnemental vise à rendre compte des relations entre les paramètres biologiques et environnementaux et culturels dans la santé. Selon cette approche, la santé est vue comme la résultante des interrelations entre les facteurs du système et non pas d'un élément pris séparément. Cette approche relève beaucoup des socio anthropologues de la santé qui s'intéressent aux dimensions culturelles et sociales dans la construction des maladies (Massé, 1995).

Cette perspective repose sur l'origine multifactorielle des maladies. Ainsi, si un agent pathogène est nécessaire à l'éclosion d'une maladie, il n'est pas cependant pas suffisant. Les facteurs associés à l'hôte (la personne affectée) et les facteurs associés à

l'environnement dans lequel se trouve la personne ont aussi un rôle dans l'expression de la maladie. Pour Shah (1995), l'interaction entre l'agent, l'hôte et l'environnement se nomme le *triangle épidémiologique*.

II. INEGALITES SOCIALES EN SANTE

II.1. Bref aperçu de la vulnérabilité et les sources de vulnérabilité

La société renferme les communautés, mais aussi les hiérarchies, les inégalités. *Les facteurs de hiérarchisation sociale sont multiples. On retient par exemple l'âge, le sexe, l'appartenance familiale, le lignage, le groupe professionnel, la maîtrise du savoir ou de la technique, la richesse, etc.*

Dans une hiérarchie sociale, les individus ont une position sociale. Selon les sociétés, un individu peut évoluer dans une hiérarchie sociale. C'est la mobilité sociale. La mobilité sociale peut être ascendante, descendante. Pour améliorer leur position, les individus développent des stratégies sociales de divers ordres : économique, mariage, diplôme, fréquentations, etc.

Un individu est dit vulnérable si, face aux risques auxquels il est exposé, il n'a pas ou ne peut pas avoir les capacités nécessaires pour y faire face ou les amortir et atténuer leurs impacts néfastes. La nature et le degré de vulnérabilité peuvent varier selon la situation économique des ménages (niveau de revenus, épargne, biens, propriété foncière, bétail, etc.), la résidence (zones géographiques et milieu rural et urbain), le cycle de la vie (petite enfance, âge scolaire, adolescence, âge adulte, et troisième âge),

le genre (sur base de certaines croyances et pratiques culturelles), les handicaps et l'état de santé, les niveaux de connaissances ou d'instruction des individus et les relations sociales, notamment dans les sociétés marquées par des problèmes d'exclusion ou de discrimination sociales (le capital humain).

Les individus sont des êtres sociaux. Les différentes relations qu'ils entretiennent, à savoir les relations sociales, les relations économiques, les relations professionnelles, les relations de genre ou de sexe, les relations culturelles, les relations religieuses déterminent leur position sociale. Ces relations agissent ou influencent leur manière de se représenter les événements de la vie quotidienne dont la maladie et les comportements ou pratiques en rapport avec la santé, les valeurs et les significations de ces événements ou faits, les possibilités de réaction aux situations auxquelles les individus sont confrontés.

Les habitudes de vie, l'augmentation impressionnante des familles monoparentales et de l'isolement individuel, la fréquence croissante des dépressions, le manque de solidarité sociale constituent une cause importante des morbidités et du manque de santé des individus et des communautés. De même, les facteurs politiques et socioéconomiques ont une influence sur la santé des individus ou des populations.

En effet, la non priorité accordée par le politique au secteur social (santé, éducation, justice) reste une des principales faiblesses de la plupart des systèmes de santé. La pauvreté, les bidonvilles, l'exclusion sociale, la qualité de l'habitat, l'accès à l'eau potable, le chômage, la violence sociale et intrafamiliale, la pollution, etc. tout en demeurant des défis majeurs pour les sociétés actuelles, constituent des causes importantes de morbidité et du manque de santé des populations.

De ce fait, on observe qu'il y a une relation étroite entre la pauvreté, vulnérabilité et capacités.

Si les inégalités sociales sont assez fortes ou pas atténuées par des formes de solidarité, elles peuvent entraîner des conflits qui peuvent être manifestes ou latents. Les relations entre différents

groupes sociaux qui ont des intérêts différents sont des relations de pouvoir. Les groupes sociaux peuvent être des classes sociales. Les classes sociales sont constituées des acteurs sociaux qui ont des intérêts conflictuels. Les individus d'une même classe sociale ont en commun les mêmes conditions de vie, les mêmes intérêts. Ils peuvent parfois aussi avoir en commun un même projet de société. Mais les intérêts des membres d'une classe sociale sont en conflit avec ceux des autres classes sociales. C'est le conflit des classes qui oppose les classes dominées aux classes dominantes.

II.2. Bref aperçu de la notion de pauvreté

Selon le Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) de 2009 (MEMPD/INS), la pauvreté est une notion complexe et multidimensionnelle. On la perçoit sous trois plans : au plan monétaire (économique), le manque ou la non satisfaction des besoins vitaux au plan sociologique et psychologique. La pauvreté peut être un fait individuel ou un fait collectif.

- **Au plan économique** : la pauvreté est l'état d'une personne ou d'un groupe de personnes qui manque de ressources matérielles ou financières pour satisfaire ses besoins vitaux, à savoir : se vêtir, se nourrir, avoir accès à l'eau potable, se soigner, scolariser ses enfants, se loger décemment, assurer sa sécurité ;
- **Au plan sociologique**, la pauvreté se traduit par la perte d'autonomie et l'exclusion des réseaux de solidarité.

C'est aussi l'incapacité de vivre selon les normes en vigueur dans la société. En somme, la pauvreté est synonyme de dégradation des valeurs morales. Ce qui se traduit par des fléaux comme la délinquance juvénile, la prostitution, la criminalité, la débauche et par des pratiques tels que le clientélisme, le laxisme, etc. ;

- **Au plan psychologique**, la pauvreté s'apparente à un sentiment de précarité (faire pitié), de vulnérabilité, d'impuissance et d'insécurité.

Selon l'UNICEF-Côte d'Ivoire (janvier 2012), lorsqu'un ménage est pauvre, manque de ressources, il est mal placé pour gérer les risques. Par exemple, il peut ne pas envoyer ses enfants au centre de santé en cas de maladie faute de moyens nécessaires pour assurer les frais de consultation ou de déplacements, acheter les médicaments. Il peut être contraint à diminuer son capital productif afin de faire face aux frais de santé. En cas de catastrophe naturelle ou de choc économique, le ménage peut se trouver sans moyens suffisants (épargne, assurance, accès au crédit) pour gérer les conséquences du choc et se voir obligé de recourir à des stratégies d'adaptation (résilience) qui lui sont néfastes à long terme, telles que la vente de biens productifs et le retrait des enfants de l'école, ce qui implique le désinvestissement en capital productif et en capital humain. Le ménage devient ainsi encore moins productif et peut passer en dessous ou s'écarter davantage du seuil de pauvreté. Une autre caractéristique importante de la vulnérabilité économique est un état d'aversion au risque, qui peut bloquer les petits investissements nécessaires pour améliorer la productivité et le bien-être à long terme. Ce qui peut conduire à des risques sanitaires.

NB : Renforcement de la résilience des ménages aux crises alimentaires et nutritionnelles : La résilience se définit comme la capacité à faire face et résister aux crises et aux chocs.

Le concept de résilience évoque également la capacité d'adaptation, à rebondir et à prendre un nouveau départ face à la survenue d'événements inhabituels et qui peuvent avoir un caractère traumatique. L'utilisation du concept de résilience des ménages dans un contexte de chocs ou de crise alimentaire et

nutritionnelle s'apparente à la capacité des ménages à endurer les chocs à s'y adapter et à y faire face.

II.3. Déterminants sociaux qui influencent positivement ou négativement la santé d'une personne

Les principaux déterminants sont :

- Le revenu et la répartition du revenu ;
- L'instruction : plus le niveau d'instruction est élevé, moins on a des emplois dangereux);
- Le chômage et la sécurité (le diplôme donne des emplois stables);
- L'invalidité ;
- L'emploi et les conditions de travail ;
- le développement du jeune enfant ;
- Le logement ;
- L'exclusion sociale (différente de l'inclusion sociale);
- le filet de sécurité sociale ;
- les services de santé (existence, équité, accessibilité, acceptabilité, etc.);
- le statut autochtone ;
- le sexe ;
- la race ;
- la résilience ;
- *empowerment*, c'est-à-dire l'accroissement de la capacité des individus à maîtriser activement leur propre existence.

L'Empowerment /Renforcement est le processus dans lequel des individus ou des groupes agissent pour gagner la « maîtrise » de leur vie. Il vise à leur permettre d'acquérir un plus grand contrôle sur les décisions et les actions affectant leur santé dans le contexte de changement de leur environnement social et politique.

- etc.

III. RISQUES SANITAIRES ET FACTEURS DE RISQUE

Pour résoudre les problèmes de santé et partant atteindre la santé publique, il est important de comprendre les facteurs de risque individuels et communautaires. En effet, il est difficile d'aborder la problématique de la promotion de la santé sans évoquer une notion fondamentale, le risque.

Conserver la santé constitue une préoccupation majeure pour tous les individus, pour toutes les sociétés. La quête de la santé est devenue un impératif social « tout à la fois le devoir de chacun et l'objectif de tous » (M. Foucault). C'est la raison pour laquelle les Etats et les individus font des efforts pour ne pas la mettre en péril. En d'autres termes, les Etats et les individus adoptent des comportements de santé qui visent soit à perpétuer un état de bien-être, soit à réduire l'exposition aux risques pouvant mettre en péril la santé des populations. Ce qui précède soulève une question : Certains comportements ont-ils un rapport établi avec la survenue des maladies ? Pourquoi les individus adoptent-ils souvent des comportements pathogènes ?

III.1. Brève approche conceptuelle

Le risque est un danger, un dommage plus ou moins probable auquel l'on est exposé. Ainsi, on peut dire, d'une manière simple, que le concept de risque renferme toutes sortes de dangers, de dommages qui sont nuisibles au bien-être et aux droits des individus. Ils peuvent être de différentes natures : économique, politique, sanitaire, socioculturelle ou environnementale.

Les risques sanitaires sont les risques susceptibles d'affecter la santé de la population du fait d'agents infectieux (virus, bacilles), de produits chimiques (amiantes, pollution) ou de substances radioactives, de produits utilisés dans le système de soins d'actes thérapeutiques (médicaments, sang, organes) ou de dysfonctionnement, des organisations de soins (maladies nosocomiales).

Au total, on retient que la maladie existe. Mais, sa survenue peut être liée à plusieurs facteurs. Ainsi le risque de maladie est donc aussi bien une *agression extérieure* que quelque chose qui *existe en nous à l'état de latent et qui ne demande pour se développer que l'absence coupable de conscience et de vigilance*. Cas par exemple des *risques liés aux styles de vie et des risques liés aux technologies*.

Ce sont ces facteurs de risque qui expliquent donc la survenue de la maladie. Le risque s'entend ainsi comme une occurrence probable – avec des degrés- jamais une occurrence certaine. Par ailleurs, il est souvent difficile à un individu de vérifier sa vulnérabilité sur le court terme et parfois sur le long terme, ce qui lui permet de penser que « *cela n'arrive qu'aux autres* ».

III.2. Typologie des risques : les risques idiosyncratiques et les risques covariants

Selon l'UNICEF-Côte d'Ivoire (janvier 2012), on distingue deux grands types de risques : les risques idiosyncratiques et les risques covariants.

III.2.1. Les risques idiosyncratiques

Ce sont les risques qui frappent les ménages les personnes de façon individuelle.

Au niveau de l'individu, ces risques sont nombreux. On a la perte de revenu, les mauvaises récoltes, le chômage et le sous-emploi, la malnutrition, les maladies et la mortalité, la non scolarisation ou l'abandon scolaire, et les violences et les abus.

Ces risques peuvent être de grande portée et provoqués ou liés à certains événements tels que les risques covariants. Ils renferment la perte de revenu, les mauvaises récoltes, le chômage et le sous-emploi, la malnutrition les maladies et la mortalité, la non scolarisation ou l'abandon scolaire, et les violences et les abus.

On peut parler des risques à caractère social ou culturel (violence domestique, mariages précoces, enfants vivant dans la rue, etc.) et les risques à caractère économique (traite et travail des enfants).

III.2.2. Les risques covariants

Les risques covariants sont les risques qui touchent l'ensemble d'une communauté, d'une région, d'un pays. Ce sont, par exemple, les chocs économiques, climatiques ou politiques.

III.3. Facteurs de risque ou comportements de santé et les risques:

Quelques exemples

- Les facteurs de risques à l'épidémiologie : ils renferment les facteurs qui peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. Exemple, la pollution de l'environnement, la consommation d'aliments gras, le fait de déféquer dans la nature qui peut occasionner le choléra
- Les grossesses à risques : une grossesse qui présente un danger pour la mère, pour le fœtus ou encore pour la mère et le fœtus
- Le risque naturel : un phénomène naturel tel que, par exemple, les inondations, les tremblements de terre ou séismes, etc. qui sont dangereux pour les populations et leurs biens ;
- Le risque social : un événement tel que par exemple la maternité, le chômage, l'invalidité, etc.

Il y a des risques perçus (savoir par exemple que poser un acte donné occasionne une ou des maladies données) et des risques non perçus (ne pas lier le moustique au paludisme). Si on ne perçoit pas cela, on trouvera difficilement les solutions à certains problèmes de santé.

Par ailleurs, les comportements de santé peuvent trouver leurs sources/origines dans l'ancrage social :

- boire avec les autres est une dimension importante de la sociabilité, et boire dans cette circonstance « ne fait jamais de mal » ;
- la nourriture est fortement marquée socialement et les aliments les plus valorisés ne sont pas forcément les plus diététiques ;
- refuser de partager le plat de quelqu'un signifie souvent ne pas être social, être méchant ;
- fumer est sans doute une habitude nocive mais c'est aussi une façon de se présenter comme un adulte, de manifester sa virilité ou sa séduction.

L'ancrage social des comportements de santé peut avoir des conséquences pathogènes pour les individus. Les comportements de santé apparaissent souvent comme plus coûteux socialement que productifs (bénéfiques) sur le plan d'un gain en bien-être hypothétique.

III.4. Risque et gestion de l'incertitude

III.4.1. L'individu calculateur

La notion de risque est toujours liée à la prise de décision en situation d'incertitude. La prise de décision est conçue comme un acte individuel, volontaire. Les individus calculent les risques.

M. Douglas (1971-1992) situe la problématique du risque dans une perspective culturelle. Les risques (les dangers) ne sont pas des données absolues : il existe une sélection et une construction sociale des risques à travers lesquelles ceux-ci sont moralisés et politisés.

Les comportements à risque sont des actions volontaires qui ont des conséquences néfastes sur la santé des individus (Jeffrey, 1989). Cela signifie que certains, parfaitement conscients des conséquences de leurs conduites, se mettent volontairement en

situation de nuire à leur santé. Tomber malade dans un tel contexte, c'est « faire un choix ». Or, pour choisir, il faut avoir une vision claire des alternatives et des conséquences. On passe là des « comportements à risque » à la « perception du risque ».

III.4.2. La gestion de l'incertitude

Le risque exprime des probabilités de survenue d'événements et de leurs conséquences en termes de gains ou de pertes.

Ce qui suppose que des individus, des groupes, des experts disposent, ou pensent disposer, de ressources nécessaires pour parvenir à des mesures adéquates.

L'évaluation objective du risque se heurte à un contexte d'incertitude qui la rend souvent impossible : exemples, la nutrition et la gestion du risque de contamination par le virus du sida.

↓ La gestion du risque de sida

Les émotions, la subjectivité, la perception de soi, de sa propre efficacité, l'identité ; la réceptivité aux informations alarmistes et catastrophiques, ou encore la méfiance prennent le pas sur une appréciation mesurée des situations et de leurs aléas.

Lorsque le danger est perçu comme présent, pressant, on modifie son style de vie, mais en même temps, on attend des autorités publiques une volonté déterminée de bien circonscrire le danger par l'instauration de mesures coercitives comme le dépistage obligatoire. (Voir aussi gestion de la Covid-19 à travers la vaccination obligatoire)

Prévention : adoption de conduites préconisées par les campagnes d'information sanitaire, notamment le recours aux préservatifs

Protection : les conduites élaborées par les individus sur la base de leurs représentations et expériences antérieures (abstinence, la fidélité, la sélection de partenaires sexuels)

III.5. La nécessité d'une vision interactive

Tout individu est inséré dans des groupes sociaux et il adhère à leurs normes. L'adoption de certains comportements peut à la fois être bonne pour leur santé mais mauvaise pour leur identité et leur insertion sociale

De ce fait, c'est dans un contexte interactif que l'apport d'information peut produire un changement individuel par le biais de l'implication dans une action collective et d'un changement normatif. Les groupes sont un relais pour l'information et un vecteur pour le changement.

En définitive, il ressort de ce qui précède que les risques sanitaires sont en rapport avec les facteurs politiques et socioéconomiques. Lesdits facteurs ont une influence sur la santé des individus ou des populations. Ils ont aussi un rapport avec la prise de décision face à la maladie et les itinéraires thérapeutiques.

IV. DETERMINANTS DE L'UTILISATION DE L'OFFRE DE SOINS DANS UNE COMMUNAUTE

IV.1. La disponibilité

C'est l'existence de services fonctionnels (opérationnels) dans la communauté pour les activités de santé. Un centre de santé peut exister sans que les populations ne sachent les différents services qu'il offre. La première ressource qui doit être disponible pour les activités communautaires est l'information.

La disponibilité peut concerner les infrastructures (centre de santé) comme les prestations de services.

Elle est une appréciation de l'utilisateur : si l'utilisateur ne sait pas que le service existe, il n'est pas disponible pour lui.

La disponibilité des services de santé renferme au moins :

- la présence physique d'infrastructure sanitaire ;
- la disponibilité temporelle ;
- la fourniture de prestations adaptées (volume des prestations, nature des prestations).

IV.2. L'accessibilité

L'accès des communautés concerne également les infrastructures et les services. L'accessibilité s'apprécie sur le plan géographique (distance) et financier (capacité à payer pour les prestations) mais aussi sur le plan psychologique. Au niveau communautaire, l'accessibilité est également une appréciation de l'utilisateur.

Au total, l'accessibilité renferme : l'absence de discrimination, l'accessibilité physique, l'accessibilité économique, et l'accessibilité de l'information.

IV.3. L'utilisation

Elle définit le premier contact avec le service et démontre qu'il a été utilisé au moins une fois.

IV.4. La continuité

Un service est continu quand il est disponible sans interruption et à la demande. La continuité concerne l'offre et l'utilisation.

IV.5. La qualité

C'est une caractéristique du service offert. Exemple : la qualité de la vaccination est fonction de la chaîne de froid, la date de péremption du vaccin.

La qualité fait référence aussi aux installations, aux biens et services en matière de santé. Ces éléments doivent être, vis-à-vis des populations, appropriés et de bonne qualité. Les prestations doivent être de qualité : personnel bien formé, respect des heures

de travail, administration de soins de qualité, respect de l'équité, respect des normes sanitaires, etc.

IV.6. L'acceptabilité

Elle est d'ordre psychologique et renvoie aux installations, aux biens et services en matière de santé.

Ces éléments doivent être appropriés sur le plan culturel et respectés les exigences en rapport avec le sexe et les différentes tranches d'âge.

IV.7. La commodité

On peut évoquer l'organisation du système de santé et de la capacité des populations à s'adapter à celui-ci : jours et heures d'ouverture des services de santé, présence régulière du personnel de santé, le temps d'attente, le coût des prestations, la prise en charge des urgences, etc.

En définitive, l'utilisation des services de santé modernes est fonction de ces différents facteurs auxquels s'ajoutent :

- la culture, des représentations, des croyances ;
- les relations sociales, du support social ;
- l'accessibilité et l'acceptabilité des services de santé basée sur des expériences antérieures.

Par ailleurs, on retient aussi que les classes sociales les plus aisées utilisent plus les services de santé et développent une forte consommation médicale que les classes sociales défavorisées et ce, pour différentes raisons :

- les classes sociales aisées sont plus ouvertes ou exposées à la culture médicale ;
- l'entourage est moins sollicité en cas de maladie ;

- les classes sociales aisées ont un pouvoir économique élevé qui leur permet d'accéder facilement aux services de santé modernes ;
- le comportement des médecins ou des professionnels de la santé varie selon la classe sociale du malade ;
- etc.

V. LES RELATIONS ENTRE LES INDIVIDUS DANS LES CENTRES DE SANTE

V.1. Les rapports entre les professionnels de santé à l'hôpital

Chaque groupe professionnel a des raisons différentes de travailler à l'hôpital : infirmiers, médecins, aides-soignants. Car chaque professionnel y développe ses propres objectifs à atteindre, spécifiques et limités dans le temps. Toute cette diversité d'objectifs affecte la division du travail de l'institution, à savoir non seulement quelles tâches chaque personne est supposée accomplir, mais aussi comment elle s'y prend pour y parvenir.

Etant donné que les objectifs individuels ne coïncident pas avec ceux effectivement programmés par les législateurs administratifs (l'ETAT), la réalisation ou l'atteinte des objectifs de chacun requiert inévitablement la coopération des collègues de travail.

Le mode de travail choisi par chaque agent de santé est très étroitement lié à sa façon de voir la médecine ou la structure dans laquelle il travaille, c'est-à-dire l'hôpital. Seul un processus continu, entraînant des accords tacites, des arrangements non officiels et des décisions officielles entre les divers groupes et des individus, au sujet de la stratégie de l'organisation globale, de la manière de diviser le travail, permet le fonctionnement de telle(s) organisation(s). Les organisations doivent dès lors être conceptualisées comme des systèmes de négociation permanente ;

La négociation est un moyen pour obtenir que les choses se fassent. Elle est utilisée pour que se fasse ce que chaque acteur, c'est-à-dire une personne, un groupe, une organisation, une nation, etc. souhaite voir fait ou accompli. Il est par conséquent intéressant d'analyser suivant Anselm L. Strauss (1992), la profession médicale comme un monde non homogène en constante évolution, composé de « segments » porteurs chacun de conceptions (idéologiques) différentes quant à la spécificité de leur pratique et de leurs activités centrales, porteurs aussi d'identités différentes, et qui se forment, se maintiennent, se développent ou/et disparaissent.

V.2. Les interactions entre la famille et les professionnels de la santé

Différents types d'interactions s'observent à l'hôpital : interactions entre les malades, leur famille et les professionnels de la santé. Le processus thérapeutique met aussi face à face les agents de santé et les familles ou les accompagnants des patients qui **« pallient très souvent aux carences de l'hôpital »**. Ce qui fait des familles ou des accompagnants des **« gardes-malades »** selon l'expression de Hours (1985). Ils sont en général, les **« premiers interlocuteurs des soignants, ils assurent habituellement plusieurs services à leurs proches alités (nourriture, hygiène du corps, achats des médicaments, etc.) »**.

Ils participent à l'amélioration et au confort de leurs proches lors de leur séjour dans service de santé.

Si les relations entre les **« gardes-malades »** sont tendues ou ne sont pas bonnes, ou si le **dialogue thérapeutique** entre ceux-ci et le personnel soignant n'est pas bon, cela peut **affecter négativement l'observance thérapeutique**.

VI. LES CONDITIONS D'ADOPTION DE COMPORTEMENT EN SANTE

Tout individu est inséré dans des groupes sociaux et il adhère à leurs normes. L'adoption de certains comportements peut à la fois être bonne pour leur santé mais mauvaise pour leur identité et leur insertion sociale.

Les comportements de santé peuvent trouver leurs sources/origines dans l'ancrage social. L'ancrage social des comportements de santé peut avoir des conséquences pathogènes pour les individus. Les comportements de santé apparaissent souvent comme plus coûteux socialement que productifs (bénéfiques) sur le plan d'un gain en bien-être hypothétique.

L'environnement physique et social ou socio-économique influence souvent le comportement des individus (ex: effet d'exposition, liaison amoureuse contextuelle, les individus de la pègre, etc.). Il en va de même de la position sociale des individus qui engendre parfois des comportements qui agissent à leur tour sur la santé.

Les facteurs essentiels qui influencent le changement de comportement sont :

- **les résultats attendus** : lorsqu'on envisage de changer de comportement, est-ce que le public s'attend à des résultats positifs ou négatifs ?
- **l'intention** : est-ce que l'individu ou la population a exprimé une intention ferme ou est-ce qu'il/qu'elle s'est déjà engagé(e) à adopter le comportement ?
- **l'image personnelle** : est-ce que le comportement est compatible avec l'image personnelle de l'individu ?
- **les capacités** : est-ce que l'individu a les capacités nécessaires pour adopter le nouveau comportement ?

- **l'efficacité personnelle** : est-ce que l'individu est confiant qu'il peut adopter le nouveau comportement ?
- **les émotions** : si l'individu choisit d'adopter le nouveau comportement, est-ce qu'il ressent un sentiment positif à le faire (plaisir, enthousiasme, joie) plutôt qu'une émotion négative ?
- **les normes sociales perçues** : est-ce que l'individu ressent une pression sociale (de l'ensemble de la société ou d'un sous-groupe social) plus forte la poussant à adopter le comportement plutôt qu'à ne pas l'adopter ? Comment l'individu perçoit-il les sentiments ou la réaction de la communauté lorsqu'il adopte ce nouveau comportement ? Est-ce que l'individu pense que le nouveau comportement serait en contradiction avec les normes sociales en place ?

Outre ces facteurs, on peut citer :

- **les services de santé** : quels sont les services offerts par le centre de santé ? Constituent-ils un obstacle ou un avantage pour l'individu ou la population cible qui fait appel à ces services ?
- **les connaissances** : quel est le niveau de connaissances de l'individu ou de la population cible par rapport au problème de santé ? Qu'est-ce qu'il/elle sait du comportement correct qu'il faut adopter face à ce problème ?
- **la compatibilité du comportement** : est-ce que le nouveau comportement est compatible avec son attitude normale ? Est-ce qu'il/elle pratique actuellement des comportements similaires ou semblables ?

VII. QUELQUES THEORIES DU COMPORTEMENT DES INDIVIDUS EN MATIERE DE SANTE

Il est important de chercher à comprendre pourquoi les individus adoptent tel ou tel comportement en matière de santé. Plus on a des informations relatives aux facteurs qui sous-tendent l'adoption d'une pratique (comportement) liée à la santé, plus on est en mesure de concevoir avec succès une intervention qui puisse influencer sur cette pratique.

Plusieurs théories permettent d'expliquer l'adoption ou non d'un comportement en matière de santé. Parmi celles-ci, on peut noter : le modèle des croyances relatives à la santé, la théorie de l'action raisonnée, la théorie sociale cognitive et le modèle de comportement planifié ou le modèle transthéorique.

VII.1. Le modèle des croyances relatives à la santé (Health belief model)

Ce modèle suppose que l'adoption d'un comportement nouveau en santé est parfois liée aux croyances : exemple l'utilisation des moyens contraceptifs modernes. Ce modèle suggère que le comportement en matière de santé est fonction de 4 croyances :

- le sentiment personnel d'une prédisposition à une menace de maladie ;
- la perception de la gravité de son état de maladie ;
- la perception de l'efficacité d'un comportement particulier face à la maladie ou à l'état de santé ;
- la perception des obstacles à ce comportement.

Ces facteurs mentaux déterminent le penchant d'un individu vers l'action/comportement.

VII.2. La théorie de l'action raisonnée

Elle étudie les rapports entre les croyances, les attitudes, les intentions et le comportement.

Elle part de l'hypothèse que pour modifier un comportement donné, il faut nécessairement modifier la structure cognitive qui la sous-tend. Elle est beaucoup plus perçue comme une série d'hypothèses.

- un comportement est essentiellement fonction de l'intention de la personne d'avoir ce comportement ;

- l'intention d'avoir ce comportement est perçue comme étant fonction de 2 facteurs que sont le facteur personnel (attitude de l'individu par rapport au comportement. Il s'agit ici de savoir si le comportement en question donnera des résultats sûrs) et le facteur social ou la norme subjective associée au comportement (l'attitude de l'individu qui se demande si les autres pensent qu'il devrait avoir un comportement donné).

VII.3. La théorie sociale cognitive

Elle étudie de façon très précise les obstacles potentiels aux changements personnels. Selon cette théorie, il existe 2 séries de connaissances importantes pour la compréhension et la modification du comportement : les résultats attendus et l'efficacité personnelle

- les résultats attendus sont l'interprétation par un individu des conséquences de son comportement ;
- l'efficacité personnelle d'un individu réside dans la croyance en sa capacité, la confiance dans son comportement et son désir de persévérer.

VII.4. Le modèle de comportement planifié ou le modèle transthéorique

Le modèle de comportement planifié essaie d'expliquer le comportement de santé sans tenir compte de facteurs théoriques précis. Le modèle postule que le changement de comportement s'opère selon les étapes suivantes :

- Pré-conscience (pré-contemplation). Les personnes qui se trouvent à ce stade n'ont nulle intention de changer de comportement dans un avenir prévisible, ne sont pas conscientes du risque ou rejettent les conséquences d'un comportement à risque.
- Conscience (contemplation). Les sujets sont conscients, qu'il y a un problème, pensent sérieusement à le résoudre, mais n'ont pas encore pris la résolution d'agir.
- Intention (préparation). A ce stade, on a l'intention d'agir dans un avenir proche, mais on a dû, dans un passé récent, entreprendre une action incohérente.

- Action. C'est l'étape où l'on modifie son comportement, ses expériences ou l'environnement pour surmonter ses problèmes ; le changement de comportement est relativement nouveau.

- Maintien. Les sujets font des efforts pour éviter une rechute et garder le nouveau comportement pendant longtemps.

Le modèle suppose que l'intention de changer peut-être inexistante au départ, présente mais faible ensuite, puis devenir plus forte ; ce qui correspond chez les individus à des essais de comportement incohérents dans un premier temps, avant l'adoption définitive du nouveau comportement qui devient partie intégrante de leur vie. Le passage d'une de ces étapes à l'autre peut varier considérablement d'une population à l'autre et d'un individu à l'autre. Certaines personnes peuvent demeurer à l'étape de la contemplation pendant des mois ou des années ; d'autres vont se déplacer de long en large entre les étapes. Tout le monde est susceptible de rechuter.

Au demeurant, le modèle de changement de comportement se présente souvent comme un processus progressif composé d'étapes identifiables. Le changement à long terme s'opère au fur et à mesure que l'on acquiert des compétences et de plus de confiance à travers des essais-erreurs suivis de renforcements. Le modèle de changement de comportement que les professionnels de la santé appliquent le plus aujourd'hui, c'est le modèle des Etapes de changement ou Modèle transthéorique.

SUPPORT DE COURS DE ANTHROPOLOGIE DE LA SANTE

SOMMAIRE

INTRODUCTION : OBJECTIF DU COURS.....	3
I. DEFINITION DE L'ANTHROPOLOGIE DE LA SANTE.....	3
II. PERCEPTION DE LA SANTE ET DE LA MALADIE..	5
III. DOULEUR ET SOUFFRANCE.....	12
IV. FAMILLE ET GESTION DE LA SANTE ET DE LA MALADIE.....	14
V. LOGIQUES SOCIALES DES SOINS.....	20
CONCLUSION	

INTRODUCTION : OBJECTIF DU COURS

Ce cours est une contribution à la formation des futurs agents de santé publique. Il vise à enrichir leur formation de nouvelles problématiques en matière de réflexion sur les questions de santé et de maladie.

« La maladie et la santé se définissent () en fonction des exigences et des attentes liées à notre environnement, à nos insertions et à nos relations, familiales et professionnelles par exemple, et constituent, au sens propre, des états sociaux » (Claudine Herzlich et Philippe Adam, 1994 :7). La maladie et la guérison ne se résument pas seulement à la biologie de l'organisme. L'étude des dimensions sociales et culturelles de la maladie est aussi importante.

En d'autres termes, les seuls aspects médicaux ne suffisent pas pour le succès d'un programme de santé, pour la prise en charge correcte d'un patient/client. La compréhension et la résolution des problèmes de santé publique nécessitent l'implication des autres sciences de la société et de la culture notamment la sociologie et l'anthropologie. D'où l'intérêt de cet enseignement.

I. DEFINITION DE L'ANTHROPOLOGIE DE LA SANTE

L'anthropologie de la santé ou l'anthropologie médicale est une sous discipline de l'anthropologie générale, science sociale, qui a pour vocation l'étude de l'homme dans sa totalité, sans distinction de couleur, de race, de culture.

« Mais l'anthropologie de la santé en tant que sous-discipline est relativement récente, et s'est constituée aux Etats-Unis au cours des années 1960 sous le nom de medical anthropology. Le terme français anthropologie de la santé témoigne d'un souci de ne pas limiter la perspective au traitement des maladies, mais de prendre

en compte l'ensemble des composantes sociales et culturelles qui interviennent dans la santé » (J.P. Olivier de Sardan, 2006).

Selon Raymond Massé (1995), *l'anthropologie de la santé se veut une analyse des façons dont les gens, dans diverses cultures et divers sous-groupes sociaux à l'intérieur de chaque culture, reconnaissent et définissent leurs problèmes de santé, traitent leurs malades et protègent leur santé.*

Elle se donne comme principaux objets d'étude, les conceptions populaires et professionnelles des causes des problèmes de santé, la nature des traitements de la maladie, les thérapeutes qui appliquent ces traitements, les processus par lesquels les individus recherchent de l'aide et les institutions qui régissent l'espace socioculturel de la santé. Elle prend ainsi en compte la santé et la maladie.

La définition que Jean Benoist (1996) donne à cette discipline rejoint celle de Massé. Pour lui, il s'agit pour cette discipline de voir, de relever, de montrer, comment dans les sociétés très diverses, se construisent les rapports à la maladie et aux soins, et de suivre la façon dont cohabitent souvent des pratiques différentes. En d'autres mots, l'anthropologie médicale s'intéresse aux croyances et pratiques en rapport/liées à la/avec la maladie. Sa vocation (tâche) *est d'étudier comment les cultures, à travers les manifestations qui leur sont propres de la pratique sociale – le « comportement face à la maladie » l'activité des spécialistes du diagnostic et de la guérison, les rites de guérison – formulent la réalité de diverses façons, et comment ce qui se veut connaissance, de même que le sens donné au langage s'organise par rapport à ces différentes formes de la réalité.*

Quelle que soit la définition retenue, l'anthropologie de la santé s'intéresse à la manière dont les savoirs d'un milieu donné dont

ceux de la biomédecine (médecine officielle) conçoivent la maladie et lui apportent une thérapie (une réponse).

« Les concepts et les outils anthropologiques aident à mettre en évidence que la maladie ne se résume pas à une réalité biologique ou physiologique, mais qu'elle se réfère à des modèles d'interprétation enracinés dans un réseau complexe de signes, structurés autour de formes culturelles et exprimés à travers un langage de la souffrance. L'anthropologue peut éclairer le soignant sur son fonctionnement professionnel, sa communication verbale et intraverbale, les valeurs respectives sous-tendant les discours et les questionnements du patient comme ceux du soignant » (Anne-Marie Begué-Simon).

II. PERCEPTION DE LA SANTE ET DE LA MALADIE

II.1. La santé

La santé, selon l'OMS, est un état de complet bien-être physique, mental (moral) et social. Elle est absence de maladie, capacité de travailler. Lorsqu'on a la santé, on peut tout faire. Le travail et l'activité participent à la préservation de la santé.

La santé est une notion normative. Elle dépasse l'état corporel. Elle englobe le physique (bien-être physique), le psychologique (mental (moral), absence de souci par exemple : avoir son enfant, son mari, malade), l'efficience (efficacité au moindre coût) dans l'activité, l'harmonie dans les relations avec les autres membres de la société. Être en bonne santé, c'est être donc en équilibre.

Selon Sainte Hildegarde De Bingen, la santé relève de l'équilibre entre le temps de travail, le temps de prières et le temps de repos et une bonne alimentation. Pour faire face au désordre qui rend l'homme malade,

il faut « une thérapie de l'âme qui est la clé de tout. Une psychothérapie qui met la foi en Dieu au cœur de la démarche de guérison et de santé. » (Père Francis Barbey, 2022).

La santé est dynamique. Elle évolue selon le temps et le contexte (saison sèche, saison des pluies, guerres/conflits, etc.). La santé est une affaire à la fois individuelle et collective. La santé publique, selon l'OMS, est « la prise en charge collective de la santé d'une population dans son milieu de vie, qu'il s'agisse de soins, prévention, éducation ou hygiène sociale ». Les différentes actions à mener dans ce contexte vont porter à la fois sur les individus, leurs comportements et leur environnement.

La santé est perçue par chaque communauté d'une manière différente. En effet, ce que les Européens perçoivent comme étant la santé peut parfaitement être perçu par un Africain comme invivable et inversement. *En somme, à des perceptions différentes correspondent des besoins différents et des réponses différentes. En d'autres termes, la culture sanitaire varie d'un milieu à un autre.*

II.2. La maladie

La maladie est un processus biologique ou psychologique qui a pour conséquence le mauvais état de santé; elle conduit à une rupture d'équilibre chez un individu.

La maladie est une régression générale de la vie de l'homme, dans ses relations et ses activités. La maladie n'est pas seulement la souffrance du corps annonciatrice de la mort, la douleur physique (la faim, la douleur sont des états physiologiques). La maladie est un processus ; elle a un caractère graduel.

La maladie est aussi morale et n'autorise pas l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Selon une vision économique évoquée par Talcott Parsons, une des conséquences sociales de la maladie est qu'en réduisant la capacité de production d'un individu ou en

empêchant un individu de travailler par exemple, elle le situe dans la déviance ; car il devient improductif et nécessite/exige qu'on le prenne en charge.

La maladie est un fait ou phénomène social (ou de société). La société est un facteur de son déclenchement ou de sa guérison. Il ne faut pas donc la réduire au corps et à la psyché des individus (malades). Aucune maladie n'est définie à elle seule, en elle-même. La maladie n'est pas une donnée ; elle n'existe, n'est définie que par rapport à une autre ou à d'autres.

Si l'on avance que « la santé n'a pas de prix », il faut cependant noter que la maladie a un coût : social, économique, psychologique.

En référence au coût de la maladie, on peut observer qu'en déclarant une personne malade, le médecin lui assigne une position dans la société. Penser au statut du patient, c'est chercher à comprendre le rapport du malade avec la médecine, c'est-à-dire comment le malade vit-il sa maladie à travers le rapport aux institutions de soins ? Comment la prise en charge (PEC) médicale contribue-t-elle à modeler son identité ? Comment, à travers la médecine, l'individu vit-il, aujourd'hui sa place dans la société ?

II.3. Les représentations sociales de la maladie

Elles sont vues comme des formes particulières (systèmes de prescription, d'inhibitions, de tolérances ou de préjugés) qui participent à chaque fois, de la vision globale qu'une société se constitue d'elle-même. Ainsi, selon Canguilem (1966) cité par Marie-Noëlle Schurmans (2000), les états pathologiques, somatiques et psychiques, apparaissent donc des exagérations dont les lois sont cependant identiques à celles des états naturels.

Être **fou** correspond à être **autre** et non pas seulement à être différent, en excès ou en pénurie (différence qualitative de l'altérité). Canguilem (1966) écrit : « *l'aliénation ne se laisse pas réduire uniquement à un fait de maladie, déterminé par sa référence à une image ou une idée précise de l'être moyen ou normal. C'est intuitivement que nous qualifions un autre homme d'aliéné et cela, en tant qu'hommes et non en tant que spécialistes. L'aliéné est sorti du cadre non pas tant par rapport aux autres hommes que par rapport à la vie, il n'est pas tant dévié que différent* ».

II.4. Les causes de la maladie

Comme tous les autres événements au cours de la vie de l'homme, la maladie exige une explication. En d'autres termes, elle exige que l'on cherche à comprendre sa nature, déterminer les causes de son apparition. Les actions à mettre en œuvre ou à entreprendre en vue de la vaincre sont fonction ou en rapport avec la compréhension de sa nature et la connaissance ou l'identification de ses causes.

Cette conception de la maladie est individuelle, sociale et culturelle/religieuse. L'interprétation de la maladie et ses symptômes est culturelle. A travers les conceptions de la maladie, l'on évoque la société, les rapports qu'on entretient avec elle. En ce sens, la maladie apparaît comme une métaphore. Elle est comme le mentionne Claudine Herzlich (1994 :202) « *un support de sens, de signifiant dont le signifié est le rapport de l'individu à l'ordre social* ». Dans le même ordre d'idée, Byron Good et Marie-Jo Delvecchio-Good écrivent que « *toute maladie est phénomène signifiant et l'activité médicale est toujours interprétative. Le médecin interprète les symptômes ressentis par son patient et les retraduit dans les catégories du savoir médical fondées sur des notions biologiques. Le malade de son côté, possède son propre point de vue concernant son état et s'est forgé, à son propos, un « modèle explicatif » ; celui-ci peut être en partie individuel mais*

il est enraciné dans la culture » (in Philippe Adam et Claudine Herzlich, Page 61).

Suivant ce qui vient d'être dit au sujet de la conception de la maladie en Afrique, la persécution justifie la plupart du temps l'apparition de la maladie (le milieu physique rend malade (causes naturelles); transgressions des interdits sexuels, alimentaires, sexuels, matrimoniaux, exemple de la lèpre au Sénégal; transgressions des obligations rituelles et la responsabilité divine à travers la punition des mécréants par Dieu). Ce qui fait dire à Didier Fassin (1992 : 139) que *« la persécution paraît donc fonder la théorie de la maladie et du malheur dans les sociétés traditionnelles africaines, et a ainsi pu être opposée à la culpabilisation, c'est-à-dire à l'intériorisation de la faute, dans les sociétés chrétiennes : il est bien connu, par exemple, qu'en Afrique le malade déprimé cherche son persécuteur, alors qu'en Occident il s'accuse de tous les maux ».*

Toutefois, les représentations que l'on a de la souffrance, la douleur (la maladie) ne sont pas nécessairement celles du groupe ou du milieu culturel. Elles peuvent varier en fonction de nouvelles expériences (de maladie).

Ainsi, au plan religieux, la maladie, selon Sainte Hildegarde De Bingen, la maladie est le signe d'un ordre rompu dans la vie de l'homme par l'homme : *« lorsque l'homme n'est plus en équilibre avec Dieu et la nature ainsi qu'avec lui-même et les autres, il peut tomber malade, mentalement et physiquement (). Les vices ont une conséquence directe sur la santé. Les vices sont en opposition des vertus qui, elles, maintiennent l'équilibre chez l'homme. Les vices nourrissent des désordres qui rendent l'homme malade. A titre d'exemple, la dureté du cœur donne des ulcères de l'estomac et de l'intestin ; la colère, la rage ou l'agressivité donne des infections et des mycoses dans l'estomac et l'intestin... »* (Père Francis Barbey, 2022).

En définitive, on peut retenir que les interprétations culturelles et sociales de la santé et de la maladie renvoient à la perception, au sentiment que les individus se font de la santé et de la maladie. Elles s'inscrivent dans la vision du monde des différentes collectivités humaines. Par vision du monde, il faut entendre tous les aspects de la vie humaine : la personne, le sacré, la connaissance, les valeurs, le temps, la mort, etc.

Chercher à donner une signification à la maladie, au malheur, à l'infortune (ne pas pouvoir se reproduire par exemple), c'est chercher à la dompter, à la connaître (plan cognitif) en vue de la vaincre, d'y remédier ou la prévenir (plan pratique, concret ; ce qui renvoie au comportement à adopter).

Les attitudes et les comportements, les décisions face à la maladie, la quête de la guérison ou les itinéraires thérapeutiques sont fonction de ces interprétations culturelles et sociales.

Les comportements, les interprétations des maladies sont fonction des **facteurs socio-culturels** qui sont l'ensemble des pratiques, des croyances, des attitudes, des savoir-faire, des valeurs, par lesquels une société organise sa vie, maîtrise son environnement et assure la continuité de son système social, économique et culturel. Il convient de noter que les contacts modifient aussi les cultures.

II.5. Les bénéfices de la maladie

II.5.1. Les bénéfices primaires de la maladie: Maladie comme source d'apaisement et de soulagement

Les bénéfices primaires jouent un rôle dans le déclenchement de la maladie ou de l'accident, soit comme cause à part entière soit comme facteur déclenchant. Ainsi, la maladie permet d'apporter une solution à une situation de tension interne ou de souffrance narcissique peu supportable : la maladie apaise et soulage.

II.5.2. Les bénéfices secondaires : Maladie comme un moyen de libération

Les bénéfices secondaires résultent des conséquences de la maladie sans intervenir directement dans son apparition, même s'ils peuvent favoriser sa pérennisation. Certains bénéfices sont conscients et connus du malade (arrêt de travail pour une maladie) alors que d'autres sont inconscients : se soustraire à des relations frustrantes, éviter les obligations familiales et sociales, fuir dans l'imaginaire et la pensée magique, être reconnu comme malade par l'entourage, être materné...

Lorsque ces différents bénéfices sont plus importants dans l'économie du malade que ceux qu'il trouve dans son fonctionnement de sujet sain, le sujet peut avoir des difficultés à guérir de sa maladie.

La maladie peut apparaître comme un moyen de libération de l'individu, c'est-à-dire une occasion pour l'individu d'échapper à un rôle social qu'il trouve contraignant (échapper à un danger pour raison de maladie, tomber malade pour se libérer d'un mari « chaud lapin »). A ce propos, Philippe Adam et Claudine Herzlich (sous la direction de François de Singly), écrivent : « En ce cas, la maladie, loin de ne représenter qu'un cortège de destruction, permet de retrouver le « vrai sens de la vie » qui ne réside pas dans sa dimension sociale ».

Outre ce fait, dans le cas des maladies chroniques ou graves, la maladie offre la possibilité d'une révélation voire d'un dépassement de soi à travers le combat ou la lutte farouche que mène le malade pour éviter la mort. On note encore avec Philippe Adam et Claudine Herzlich que « Pour d'autres personnes qui ont eu souvent l'expérience d'une maladie grave, la maladie est un « métier ». Elle n'entraîne pas de transformation radicale dans l'image que la personne a d'elle-même ; celle-ci conserve un rôle valorisé et

préserve son identité sociale par la lutte contre la maladie. Ce combat devient l'élément central de sa vie, l'équivalent d'une activité professionnelle, et d'une intégration sociale spécifique mais persistante ».

III. DOULEUR ET SOUFFRANCE

III.1. La douleur

III.1.1. La douleur, un fait incommunicable

Selon David Le Breton, il n'y a pas de douleur sans souffrance. La douleur est souvent *incommunicable*. « *La douleur tue la parole à sa source* » (Le Breton, 1995 : 40). C'est la raison pour laquelle, le malade utilise souvent des métaphores pour se faire comprendre, pour exprimer la douleur : « *c'est comme je me donnais des coups de marteaux sur le pied... C'est comme des coups de couteaux ou des morsures* ». Pourtant, le malade n'a jamais reçu de coups de couteau ou n'a jamais été mordu par aucun animal. On ne peut donc pas saisir l'intensité de la douleur de l'autre. Ainsi, « *les maux remplacent les mots* » selon l'expression de Foucart (2003 : 109). Ce qui amène parfois les autres à douter de la douleur du malade.

III.1.2. La conception doloriste ou conception chrétienne de la douleur

Selon les récits de la Bible, la douleur est associée au péché originel (Adam & Eve). La douleur et la souffrance sont un châtiment pour l'homme à cause de son non-respect des commandements de Dieu.

III.1.3. La construction sociale de la douleur

La société détermine ce qui est acceptable et excès de souffrance pour les individus. L'acceptabilité et l'excès de souffrance varient selon les cultures.

L'expérience individuelle se positionne ensuite entre ces balises. Lorsque la réaction à la douleur ne s'inscrit pas dans le cadre culturel, un doute s'installe à propos de l'authenticité de cette douleur. Ce qui justifie souvent le recours aux dieux tutélaires, aux devins, aux hommes de Dieu.

Toutefois, dans les sociétés modernes et notamment grâce à la médecine moderne, toute douleur est une souffrance inutile au plan moral, au plan culturel avec le développement de l'anesthésie et des analgésiques : accouchement sans douleur, se faire opérer endormi, etc. En cas d'échec, on évoque le destin.

III.1.4. Le sens de la douleur selon le contexte

Le sens de la douleur varie selon le contexte. Un individu qui souffre vit sa douleur différemment selon les personnes qui se trouvent autour de lui. Ainsi, « Devant l'infirmière ou sa mère, il laissera libre cours à sa plainte alors que devant les collègues de travail, il sera fort et en contrôle » (Edith Pouliot).

III.2. La souffrance

III.2.1. Bref aperçu de la notion de souffrance

La souffrance est tout manque perçu par une population, un individu comme un mal-être. Il ne s'agit donc pas uniquement de la souffrance physique : toute souffrance n'implique pas toujours une douleur physique. La souffrance est vue comme une perte de sens. L'individu change, se referme sur lui-même pour tenter de surmonter son enfer en silence. Foucart fait observer que « *La souffrance se prouve, elle s'éprouve* » (Foucart, 2003 :111).

La souffrance est une notion objective par rapport aux critères d'une population et elle est fonction des facteurs socio-culturels.

La souffrance chez un individu ou une communauté s'exprime par une demande qui est le comportement par lequel un individu, une communauté cherche un soulagement de sa souffrance.

La souffrance peut aussi être entendue comme crise de la confiance en soi, dans les autres, dans le monde.

La confiance est un sentiment de base de la vie sociale et psychique. Elle est une composante centrale d'un ensemble généralisé de relations à l'environnement social et psychique.

III.2.2. La souffrance et son rapport avec l'espace

La maladie désorganise les rapports et les ajustements d'une personne à la société notamment ses insertions immédiates (famille, travail, vie publique...). Pour des malades, les relations se raréfient et le réseau social finit par se restreindre à quelques membres de la famille. C'est ce que Foucart nomme le *rétrécissement du milieu*.

Certains membres de l'entourage évitent de fréquenter le malade parce qu'il n'est pas productif (le malade peut connaître un appauvrissement économique du fait de l'abandon de son activité professionnelle, sa fréquentation est une perte de temps (relation d'aide sans contre-don).

Cette situation synonyme d'« *absence d'écoute ou d'attention de la part de l'entourage amène le malade à penser que ses proches se lassent d'écouter sa douleur et qu'il vaut mieux ne plus en parler et conserver les liens restant avec les quelques personnes encore auprès de lui* ».

IV. FAMILLE ET GESTION DE LA SANTE ET DE LA MALADIE

IV.1. La famille

La famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines, selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss.

L'expérience individuelle se positionne ensuite entre ces balises. Lorsque la réaction à la douleur ne s'inscrit pas dans le cadre culturel, un doute s'installe à propos de l'authenticité de cette douleur. Ce qui justifie souvent le recours aux dieux tutélaires, aux devins, aux hommes de Dieu.

Toutefois, dans les sociétés modernes et notamment grâce à la médecine moderne, toute douleur est une souffrance inutile au plan moral, au plan culturel avec le développement de l'anesthésie et des analgésiques : accouchement sans douleur, se faire opérer endormi, etc. En cas d'échec, on évoque le destin.

III.1.4. Le sens de la douleur selon le contexte

Le sens de la douleur varie selon le contexte. Un individu qui souffre vit sa douleur différemment selon les personnes qui se trouvent autour de lui. Ainsi, « Devant l'infirmière ou sa mère, il laissera libre cours à sa plainte alors que devant les collègues de travail, il sera fort et en contrôle » (Edith Pouliot).

III.2. La souffrance

III.2.1. Bref aperçu de la notion de souffrance

La souffrance est tout manque perçu par une population, un individu comme un mal-être. Il ne s'agit donc pas uniquement de la souffrance physique : toute souffrance n'implique pas toujours une douleur physique. La souffrance est vue comme une perte de sens. L'individu change, se referme sur lui-même pour tenter de surmonter son enfer en silence. Foucart fait observer que « *La souffrance se prouve, elle s'éprouve* » (Foucart, 2003 :111).

La souffrance est une notion objective par rapport aux critères d'une population et elle est fonction des facteurs socio-culturels. La souffrance chez un individu ou une communauté s'exprime par une demande qui est le comportement par lequel un individu, une communauté cherche un soulagement de sa souffrance.

La souffrance peut aussi être entendue comme crise de la confiance en soi, dans les autres, dans le monde.

La confiance est un sentiment de base de la vie sociale et psychique. Elle est une composante centrale d'un ensemble généralisé de relations à l'environnement social et psychique.

III.2.2. La souffrance et son rapport avec l'espace

La maladie désorganise les rapports et les ajustements d'une personne à la société notamment ses insertions immédiates (famille, travail, vie publique...). Pour des malades, les relations se raréfient et le réseau social finit par se restreindre à quelques membres de la famille. C'est ce que Foucart nomme le *rétrécissement du milieu*.

Certains membres de l'entourage évitent de fréquenter le malade parce qu'il n'est pas productif (le malade peut connaître un appauvrissement économique du fait de l'abandon de son activité professionnelle, sa fréquentation est une perte de temps (relation d'aide sans contre-don).

Cette situation synonyme d'« *absence d'écoute ou d'attention de la part de l'entourage amène le malade à penser que ses proches se lassent d'écouter sa douleur et qu'il vaut mieux ne plus en parler et conserver les liens restant avec les quelques personnes encore auprès de lui* ».

IV. FAMILLE ET GESTION DE LA SANTE ET DE LA MALADIE

IV.1. La famille

La famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines, selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss.

Elle est dotée d'un nom, d'un domicile, et crée entre ses membres une obligation de solidarité morale venant du mariage religieux et une obligation matérielle (notamment entre époux, d'une part, et entre parents et enfants, d'autre part), censée les protéger et favoriser leur développement social, physique et affectif. La famille constitue une réalité universelle, sa forme varie en fonction des sociétés, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'elle inclut ou la solidarité accordée est variable, c'est même une des notions centrales dans la culture. Il en découle de grandes différences par exemple dans le droit, dans la transmission du patrimoine ou la religion.

La famille, en tant que micro-société, est une institution sociale fondamentale soumise à des règles précises qui déterminent son fonctionnement. Sa cohésion et sa dislocation sont le reflet de la société dont elle émane car c'est la société même qui crée les conditions d'épanouissement ou de dépérissement de la famille.

La famille est la cellule de base de la société. Elle est l'institution qui, avec l'éducation dont la fonction est de modeler la personnalité de l'individu à l'intérieur de la société, permet à l'individu d'intérioriser les normes et les valeurs de la société afin de les transmettre à son tour aux générations futures (patrimoine idéologique, matériel). Mais en plus de ce rôle de transmission du patrimoine, la famille joue un rôle plus essentiel : celui de la pérennisation biologique de l'espèce humaine. Par le jeu des alliances, des règles matrimoniales et des unions, la famille assure la reproduction biologique de la société. Elle est source de sécurité, de protection physique, morale, affective, sociale et psychologique (Mariatou Koné et Kouamé N'guessan, 2005 :5).

La famille est normalement quelque chose de sacré et sa forme varie selon les sociétés. La famille, selon Claude Lévi-Strauss (1956) cité par Mariatou Koné et Kouamé N'guessan (2005 :13-14) désigne un groupe social offrant au moins trois caractéristiques :

1. *Il a son origine dans le mariage ;*
2. *Il comprend mari, femme, et enfants nés de leur union, bien que l'on puisse concevoir la présence d'autres parents agglutinés à ce noyau ;*
3. *Les membres de la famille sont unis :*
 - a. *Par des liens légaux ;*
 - b. *Par des liens économiques, et toutes sortes de droits et d'obligations ;*
 - c. *Par un réseau précis de droits et interdits sexuels, et un ensemble variable et diversifié de sentiments psychologiques tels que l'amour, l'affection, le respect, la crainte, etc.*

Le mariage est une union socialement reconnue, ayant une certaine permanence et pouvant durer toute une vie. **Les relations sexuelles ne constituent pas le mariage.** Le mariage est une institution sociale par laquelle un enfant acquiert une situation légitime dans la société, situation qui est déterminée par ses parents au sens social.

De par le mariage, la femme acquiert socialement un nom. En d'autres termes, une femme non mariée est une femme socialement sans nom.

Le nom constitue l'un des principaux éléments d'identification sociale. **Dans les sociétés africaines, il a un contenu psychosociologique significatif.**

Un Africain se marie parce qu'il veut des enfants. L'élément le plus important de la valeur d'une femme est sa fécondité. Si donc une femme se montre stérile, dans beaucoup de tribus, la famille du

mari l'autorise à prendre une autre femme ou lui fournit une autre femme pour qu'elle lui fasse des enfants. Aujourd'hui, avec la mutation des différentes sociétés, il convient de relativiser cette conception du mariage, car bien de couples ne se séparent plus pour des raisons d'enfants et certains d'entre eux procèdent ou non à l'adoption d'enfant.

Un élément important de tout système de parenté est constitué par un ensemble de règles concernant les mariages entre parents ou alliés. Il y a en premier lieu des règles qui interdisent le mariage entre certains parents.

L'inceste est constitué par le fait d'entretenir des relations sexuelles avec certains parents ou alliés dont le degré de parenté est défini par la loi ou la religion. L'inceste est, à proprement parler, le péché qui consiste à avoir des relations sexuelles avec des parents proches : père et fille, mère et fils, frère et sœur.

En d'autres termes, la prohibition de l'inceste est une interdiction sociale de rapport sexuel entre deux individus de sexe différent en raison d'un lien étroit de parenté. L'inceste est une interdiction ou condamnation d'union/mariage, de relation sexuelle entre deux individus de sexe différent appartenant à un même groupe.

Les règles ou coutumes relatives aux prohibitions de mariages ou aux mariages préférentiels, ont pour fonction sociale de préserver ou de maintenir une structure donnée de parenté en tant que système de relations. La fonction d'une coutume se rapporte au rôle qu'elle joue dans le fonctionnement du système auquel elle appartient.

On peut considérer un système familial et matrimonial comme un ensemble de dispositions permettant à plusieurs personnes de vivre ensemble et de coopérer selon les règles de vie sociale.

Un système de parenté présente un appareil complexe de lois, d'usages, de types de conduite entre parents.

La règle selon laquelle les enfants doivent non seulement aimer, mais honorer et respecter leurs père et mère, est sinon universelle du moins générale dans les sociétés humaines.

Dans le passé, la stabilité de l'ordre social, dans les sociétés africaines, dépendait beaucoup plus des systèmes de parenté que d'autres facteurs. Mais actuellement, ces systèmes ne peuvent manquer d'être affectés.

IV.2. La famille et la gestion de la santé et de la maladie

Du point de vue socio-anthropologique, en Afrique, la santé ou la maladie reste un fait collectif et familial.

La famille représente un déterminant social de santé majeur pouvant, selon le degré de sociabilité familiale, accroître ou réduire les inégalités sociales de santé. Dans la construction sociale de la santé, la famille joue un rôle important. Elle constitue un soutien matériel et moral, sa présence rassure et protège ; ce qui permet d'éviter l'isolement et le stress qui sont sources de maladies pouvant aggraver l'état du malade.

La famille, en tant que micro-société, est une institution sociale fondamentale soumise à des règles précises qui déterminent son fonctionnement. Sa cohésion et sa dislocation sont le reflet de la société dont elle émane car c'est la société même qui crée les conditions d'épanouissement ou de dépérissement de la famille.

La famille est une institution sociale dans laquelle il y a des conflits et des inégalités entre les membres. *« Les événements de santé et maladie produisent des liens familiaux, les réaffirment ou les distendent. La famille se comprend davantage en référence aux relations de soutien et de reconnaissance ».*

Ainsi, *« Dans le cas des maladies chroniques, la gestion et le partage de l'information sur le statut et l'itinéraire biographique du malade peuvent relever d'un secret de famille. La famille a la responsabilité de sensibiliser, d'éduquer ses membres sur les méthodes de prévention ».*

A ce titre, les acteurs familiaux peuvent devenir des « pseudo médecins » et produire des soins ». C'est pourquoi, le personnel de santé implique des membres de la famille dans l'éducation thérapeutique des patients en leur transmettant des compétences.

Si famille et santé vont de pair ou encore si ces deux notions sont en interaction permanente, il convient toutefois de dire qu'on doit les aborder *sans inféoder l'une à l'autre*. En d'autres termes, *associer la famille à la gestion ou la prise en charge du patient ne fait d'elle « une auxiliaire des personnels de la santé »*.

IV.3. Les interactions entre la famille et les professionnels de la santé

Différents types d'interactions s'observent à l'hôpital : interactions entre les malades, leur famille et les professionnels de la santé. Le processus thérapeutique met aussi face à face les agents de santé et les familles ou les accompagnants des patients qui « *pallient très souvent aux carences de l'hôpital* ». Ce qui fait des familles ou des accompagnants des « *gardes-malades* » selon l'expression de Hours (1985). Ils sont en général, les « *premiers interlocuteurs des soignants, ils assurent habituellement plusieurs services à leurs proches alités (nourriture, hygiène du corps, achats des médicaments, etc.)* ». Ils participent à l'amélioration et au confort de leurs proches lors de leur séjour dans service de santé.

Si les relations entre les « *gardes-malades* » sont tendues ou ne sont pas bonnes, ou si le *dialogue thérapeutique* entre ceux-ci et le personnel soignant n'est pas bon, cela peut *affecter négativement l'observance thérapeutique*.

V. LOGIQUES SOCIALES DES SOINS

V.1. L'itinéraire thérapeutique et ses déterminants

Au regard des données socio-anthropologiques, très souvent en Afrique, lorsque la maladie survient ou dès les premiers signes de la maladie, le malade et/ou la famille opte pour l'automédication.

En cas d'échec de ces premières « pratiques thérapeutiques locales ou profanes », le malade et/ou la famille se dirige chez les professionnels de la santé traditionnels et/ou modernes.

Ainsi, « *l'itinéraire thérapeutique suivi n'est pas toujours celui voulu ou choisi par le malade lui-même mais, il est aussi très souvent celui choisi et décidé par sa famille ou son réseau de soutien* ». En effet, « *les membres de l'environnement socio-familial prennent généralement d'importantes décisions dans les choix thérapeutiques. Ceci peut être davantage dû au fait qu'ils sont aussi, dans la plupart des cas, les personnes qui déploient les capitaux financiers, sociaux et culturels nécessaires pour une prise en charge durable du malade* ».

L'itinéraire thérapeutique est le cheminement d'un malade en quête d'un diagnostic et d'une thérapie. C'est le recours successif d'un patient à différents systèmes de santé (médecine moderne, médecine traditionnelle, lieux de culte, de prières) en vue d'accéder à la guérison.

Du point de vue de la population, il existe de nombreuses alternatives de services utilisées en séquence ou simultanément :

- le système de santé profane (secteur populaire);
- le recours aux services de santé traditionnels ;
- le recours aux services de santé modernes publics et privés ;
- les lieux de culte.

Les itinéraires thérapeutiques sont « une combinaison permanente de recours aux compétences des deux sphères de

la médecine (traditionnelle et moderne). Dans les deux cas, les résultats ne sont pas toujours bons » (Mariatou Koné et N'guessan Kouamé, 2005). Très souvent, la pauvreté et la cherté de la médecine moderne orientent les malades et leurs familles à la médecine traditionnelle. Par conséquent, « Le retour à l'hôpital se fait souvent dans des conditions d'extrême urgence car le malade se trouve dans un état désespéré » (Mariatou Koné et N'guessan Kouamé, 2005).

Retenons cependant que la médecine traditionnelle apparaît souvent comme « un véritable gouffre financier en raison des sacrifices qui sont requis et des objets rituels qui doivent être achetés » (Mariatou Koné et N'guessan Kouamé, 2005).

En médecine traditionnelle, le coût de la thérapie est souvent justifié par un certain nombre de raisons :

- la conservation du pouvoir thérapeutique (exiger quelque chose au patient pour ne pas perdre son pouvoir) ;
- le souhait d'obtenir la guérison : ne pas payer rend parfois le traitement inefficace et les rapports sociaux difficiles ;
- l'aumône ou le don au soignant pour préparer son éventuel retour ;
- le sacrifice émanant d'une prescription surnaturelle, c'est-à-dire commandé par les génies après une divination.

Au total, le choix des itinéraires thérapeutiques repose sur certaines logiques :

- *les causes structurelles, c'est-à-dire, la conception de la maladie, la place du patient dans la famille ou la société ;*
- *les causes conjoncturelles ou situationnelles, en d'autres termes la situation financière, les conseils de l'entourage, les relations médecin-patient.*

La prise en charge médicale génère de façon indissociable des coûts directs (frais de consultation, achat des médicaments,

frais d'hospitalisation, transport, alimentation/ nutrition, frais d'accouchement et d'examens au laboratoire) et des coûts indirects ou des coûts d'opportunité (frais de transport et d'alimentation pour celui ou celle qui accompagne le/la malade, frais informels tels que les pourboires, les frais de communication, etc.).

D'une manière générale, la prise en charge renvoie au comportement thérapeutique que peuvent avoir un patient, sa famille / son entourage, le personnel de santé face à l'apparition des premiers signes de maladies chez une personne. Elle peut être collective.

La prise en charge médicale présente souvent des obstacles qui, dans le contexte ivoirien, sont entre autres :

- L'obligation faite à l'usager de payer les prestations de soins. Les coûts des prestations sont souvent élevés alors que beaucoup de gens qui sollicitent les structures de santé sont pauvres et n'ont pas d'assurance-maladie. Ce qui crée des inégalités entre usagers des structures de santé. La mise en place de la Couverture maladie universelle pourrait réduire cet écart entre les populations ;
- les distances et la mauvaise répartition géographique des structures sanitaires ne permettent pas aux populations d'accéder rapidement aux centres de prise en charge de maladie ;
- les équipements (le plateau technique + médicaments) ne permettent pas aux populations de bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate ;
- l'indisponibilité des médicaments ;
- le manque de personnel qualifié, le zèle de certains agents de santé ;
- le mauvais accueil, le favoritisme, la fraude sur les tarifs ou le non-respect des coûts des actes de santé, etc.

Ainsi, quel que soit le système de santé sollicité, la santé a un coût direct et un coût indirect.

De ce précède, on note qu'en réalité, *les professionnels de la santé ne représentent qu'un élément de l'itinéraire thérapeutique. L'itinéraire thérapeutique d'un malade est complexe et propre à chaque malade. Il est en rapport avec la position sociale et la culture du malade. Par conséquent, les professionnels de la santé ne doivent pas s'imaginer qu'ils sont les seuls à être au cœur de la prise en charge des maladies.*

Les comportements de santé renferment différentes dimensions qui sont étroitement liées :

- les dimensions culturelles, c'est-à-dire celles relatives à des représentations, des croyances, des valeurs partagées par un groupe ;
- les dimensions sociales, c'est-à-dire celles relatives à la structuration du groupe, aux relations de pouvoir dans le groupe et la position sociale des individus dans le groupe.

La santé constitue un enjeu. L'adoption d'un comportement, le refus de l'adoption d'un comportement est fonction des facteurs environnementaux tels que les facteurs physiques, économiques, sociaux, politiques et culturels.

V.2. L'accès difficile aux médicaments par les malades et/ou leurs réseaux sociaux

Le médicament est « une substance thérapeutique pharmacologiquement active, conçue et/ou validée par la recherche médicale, produite de manière industrielle et dont la vente et l'usage sont autorisés et régis par des instances a pris une place dominante dans les soins, quelles que soient les socio-cultures » (Alice Desclaux & Marc Egrot, 2015).

Il doit être disponible et abordable. Or, il existe de « fortes disparités en matière d'accès aux médicaments dans le secteur public comme dans le secteur privé ainsi que d'écarts de prix importants freinant l'accès aux médicaments chez les populations pauvres » (Alice Desclaux & Marc Egrot, 2015).

Ainsi, poursuivent-ils « Un grand nombre de personnes souffrant de problèmes de santé ne bénéficient pas d'un traitement médical adéquat, par manque de médicaments, à cause de leur coût qui les met hors de portée des populations aux revenus limités, et du fait de l'absence de traitements pour des pathologies dites négligées ou orphelines, ou de formulations pour les enfants ».

L'achat des médicaments représente une bonne partie des dépenses individuelles de santé dans les ménages. L'automédication (moderne ou traditionnelle), pratique de soins profanes, fait partie intégrante de la vie des ménages, surtout les ménages en difficulté financière. Ce qui peut avoir un impact potentiel sur la gestion de la santé, de la maladie et des soins.

De ce qui précède, on peut retenir avec Mariatou Koné et N'guessan Kouamé (2005), s'agissant des populations de la Côte d'Ivoire, que « La maladie est devenue un indicateur qui permet de saisir l'état de décrépitude de la société et de la famille ivoiriennes ».

V.3. La logique de l'achat du médicament ou des médicaments par les malades et/ou leurs réseaux sociaux

Dans les ménages pauvres surtout, l'achat des médicaments obéit à une logique qu'évoquent ici Mariatou Koné et N'guessan Kouamé (2005). « La logique qui sous-tend l'achat des médicaments prescrits par le médecin, est une logique d'urgence définie par les parents eux-mêmes.

L'achat des médicaments s'étale dans le temps : tous les médicaments seront achetés mais au rythme de l'obtention de l'argent nécessaire. La plus ou moins grande efficacité de la solidarité familiale conditionne ce rythme.

Il y a ensuite la logique du tri : les parents achètent les médicaments supposés indispensables à la guérison, les autres étant perçus comme des médicaments de confort. Le tri se fait généralement sur la base du coût du médicament et est sous-tendu par une logique particulière à chaque famille. La priorité peut être accordée aux médicaments les plus chers sensés être les plus efficaces ou alors à ceux d'un coût moindre pour soulager quelque peu le malade ».

Parfois, quelle que soit la logique suivie, la mort peut survenir et faire établir une différence entre les personnes défuntées :

- les « bons morts » ou les « décédés » sont « inhumés » après l'organisation des « obsèques » qualifiées de « tonnerre ou Afrique étoile » ;
- les « mauvais morts », c'est-à-dire ceux qui sont « morts » qu'on « enterre » et fait les « funérailles » (Mariatou Koné et N'guessan Kouamé (2005).